



TASK FORCE PRESIDENTIELLE EBOLA 17

Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale

Système de gestion de l'incident MVE17



Rapport de Situation de la 17^{ème} Épidémie de la Maladie à Virus EBOLA /RDC

SitRep N°096/MVEBDB/19/08/2026

Date de rapportage : 19 août 2026

Date de publication : 20 août 2026



FAITS SAILLANTS (dernières 24h)

81 nouveaux cas confirmés de MVE ont été rapportés au 19 août 2026 : 56 en Ituri, 18 au Nord-Kivu et 7 au Haut-Uélé. Quarante décès confirmés ont été enregistrés, dont 23 communautaires et 17 intra-CTE. Aucune nouvelle zone de santé n'a été touchée.

CUMUL DES CAS 5 290	CUMUL DES DÉCÈS CONFIRMÉS 2 516	LETALITE 47,6%	PATIENS EN ISOLEMENT/CTE 837	CUMUL DES GUÉRIS 1 152	TAUX DE SUIVI DES CONTACTS (Du Jour) 82,9 %
--	--	-------------------------------------	---	---	---



Provinces touchées et Zones de santé touchées



6 Provinces touchées

Haut-Uélé, Ituri, Nord-Kivu,
Sud-Kivu, Tshopo & Bas Uélé



56 Zones de santé touchées sur 151
(37,1%)



246 Aires de santé touchées
Sur 3104 (7,9%)

Résumé des points clés au cours de dernières 24 heures

Au 19 août 2026, **81 nouveaux cas confirmés de MVE** ont été rapportés, contre **103 la veille**, soit une **baisse de 21,4 %**. Ils sont répartis entre l'Ituri (56), le Nord-Kivu (18) et le Haut-Uélé (7). L'Ituri demeure l'épicentre, concentrant **69,1 % des nouveaux cas**, malgré une baisse par rapport aux **82 cas rapportés la veille**.

Le nombre de **décès confirmés du jour diminue de 56 à 40 (-28,6 %)**, dont **23 décès communautaires contre 35 la veille** et **17 décès intra-CTE contre 21**. Par ailleurs, **37 patients ont été déclarés guéris**, contre 24 la veille.

Le cumul national s'établit à **5 290 cas confirmés et 2 516 décès**, avec une létalité de **47,6 % contre 47,5 % la veille**. Le nombre de zones de santé affectées demeure **stable à 56/151 (37,1 %)**, sans nouvelle extension géographique au cours des dernières 24 heures.

NB : l'augmentation du cumul est de **82 cas** malgré 81 nouveaux cas, en raison de l'intégration d'un **cas rétrospectif de la Tshopo après harmonisation des données**.

Désormais, 56 des 151 zones de santé des six provinces sont affectées depuis le début de l'épidémie en RDC. L'Ituri compte 28 zones de santé touchées sur 36, suivi du Nord-Kivu (12/34), du Haut-Uélé (6/13), de la Tshopo (7/23), du Sud-Kivu (1/34) et Bas Uélé (2/11).

Répartition des cas et décès confirmés par province touchée
(Au 19 août 2026)

Province	Total cas confirmés	Total décès (confirmés)	Létalité	Zones de santé touchées	Nouveaux cas confirmés(24h)
Ituri	4447	1 984	44,6%	28/36 (77,8 %)	56
Nord-Kivu	663	452	68,2%	12/34 (35,3 %)	18
Haut-Uélé	160	71	44,4%	6/13 (46,1 %)	7
Tshopo*	15	7	46,7%	7/23 (30,4 %)	0
Sud-Kivu	3	1	33,3%	1/34 (2,9 %)	0
Bas Uélé	2	1	50,0%	2/11(18,2%)	0
Total	5 290	2 516	47,6%	56/151 (37,1 %)	81

*Harmonisation des données avec la province de la Tshopo, ramenant le cumul des cas confirmés de 14 à 15 (+1 cas rétrospectif).

L'Ituri demeure l'épicentre de l'épidémie, concentrant **84,1 % des cas cumulés** et **69,1 % des nouveaux cas**. Malgré une baisse des nouvelles confirmations au niveau national (**81 contre 103 la veille**), le Nord-Kivu enregistre une progression de **12 à 18 nouveaux cas** et conserve une **létalité particulièrement élevée de 68,2 %**. Le Haut-Uélé reste également en transmission active avec 7 nouveaux cas. Au total, **56/151 ZS (37,1 %) sont affectées**, sans nouvelle extension géographique au cours des dernières 24 heures.

Cas et décès confirmés par province et zone de santé (situation du 19 août 2026)

Province / Zone de santé	Nombre cumulatif			Situation du jour (24h)			
	Cas (n)	Décès (n)	Létalité	Nouv. Cas	Décès communautaires (Swab+)	Décès confirmés intra-CTE	Total décès confirmés
Ituri	4447	1984	44,6%	56	13	13	26
Adja	11	1	9,1%				0
Aru	7	6	85,7%				0
Ariwara	8	2	25,0%				0
Aungba	11	5	45,5%				0
Bambu	114	26	22,8%				0
Boga	1	1	100,0%				0
Bunia	1244	389	31,3%	25	5		5
Damas	25	9	36,0%				0
Drodro	13	6	46,2%				0
Fataki	72	30	41,7%				0
Gethy	5	2	40,0%				0
Kambala	2	0	0,0%				0
Kilo	31	12	38,7%				0
Komanda	53	37	69,8%				0
Lita	186	106	57,0%				0
Logo	11	5	45,5%				0
Lolwa	17	4	23,5%				0
Mahagi	4	1	25,0%				0
Mambasa	14	7	50,0%				0
Mandima	25	16	64,0%				0
Mangala	183	105	57,4%	10	6		6

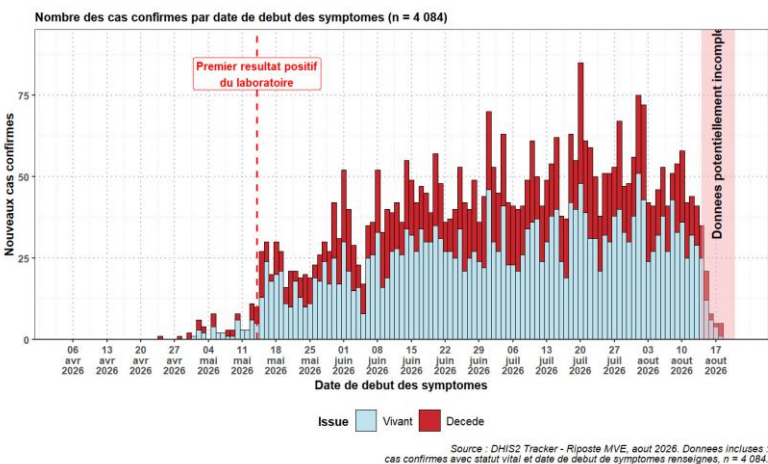
Mongbwalu	593	282	47,6%				0
Nia-Nia	182	105	57,7%	4	1		1
Nizi	567	244	43,0%	9	1		1
Nyankunde	121	35	28,9%				0
Rimba	10	4	40,0%	1	0		0
Rwampara	886	332	37,5%	7	0		0
Tchomia	51	25	49,0%				0
A ventiler	NA	187	NA			13	13
Nord-Kivu	663	452	68,2%	18	8	4	12
Beni	104	76	73,1%	6	3	2	5
Butembo	127	98	77,2%	3	0		0
Goma	1	0	0,0%				0
Kalunguta	13	6	46,2%				0
Katwa	316	210	66,5%	6	4	2	6
Kyondo	15	12	80,0%				0
Lubero	1	1	100,0%				0
Mabalako	2	1	50,0%				0
Masereka	7	4	57,1%				0
Musienene	66	38	57,6%	3	1		1
Oicha	6	4	66,7%				0
Vuhovi	5	2	40,0%				0
Haut-Uélé	160	71	44,4%	7	2	0	2
Boma Mangbetu	23	9	39,1%				0
Gombari	1	1	100,0%				0
Isiro	58	24	41,4%	3	0		0
Pawa	20	14	70,0%				0
Rungu	1	0	0,0%				0
Wamba	57	23	40,4%	4	2		2
Tshopo	15	7	46,7%	0	0	0	0
Bafwasende	1	0	0,0%				0
Kabondo	3	1	33,3%				0
Lubunga	1	0	0,0%				0
Makiso-Kisangani	6	3	50,0%				0
Mangobo	2	2	100,0%				0
Tshopo	1	0	0,0%				
Wanie-Rukula	1	1	100,0%				0
Sud-Kivu	3	1	33,3%	0	0	0	0
Miti-Murhesa	3	1	33,3%				0
Bas Uélé	2	1	50,0%	0	0	0	0
Buta	1	1	100,0%				0
Viadana	1	0	0,0%				
Total	5290	2516	47,6%	81	23	17	40

La transmission reste principalement concentrée en **Ituri (69,1 % des nouveaux cas)**, notamment à Bunia, Mangala, Nizi et Rwampara. Le **Nord-Kivu conserve une létalité élevée (68,2 %)**. Les **décès communautaires représentent 57,5 % des décès du jour (23/40)**. En Ituri, **187 décès cumulés restent à ventiler par ZS**, nécessitant la poursuite de l’harmonisation des données.

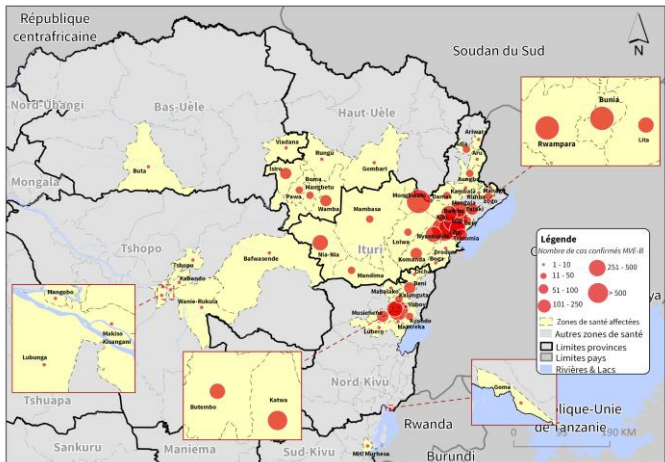
Situation des alertes notifiées par province, au 19 août 2026									
DPS	Nouvelles Alertes reçues		Total alertes	Alertes vérifiées et validées (cas suspect)		Alertes vérifiées et invalidées (non-cas suspect)		Nombre de suspects investigués	Nombre de suspects investigués et transférés au CT/CTE (du jour)
	Vivants	Décédés		Vivants	Décédés	Vivants	Décédés		
Haut-Uélé	ND	ND	0	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Bas Uélé	6	0	6	3	0	3	0	3	3
Ituri	625	60	685	132	53	365	2	148	83
Nord-Kivu	1 036	74	1110	91	71	932	0	160	88
Sud-Kivu	6	0	6	3	0	0	0	3	3
Tshopo	97	0	97	13	0	84	0	13	8
Total Général	1770	134	1 904	242	124	1384	2	327	185

Sur **1 904 alertes enregistrées**, **1 752 (92,0 %) ont été vérifiées**, dont **366 (20,9 %) validées comme cas suspects**. Parmi ces derniers, **327 (89,3 %) ont été investigués** et **185 (56,6 %) transférés vers les CT/CTE**. Le Nord-Kivu concentre **58,3 % des alertes nationales** et affiche une performance élevée de vérification (98,6 %), tandis que l’Ituri présente une performance plus faible (80,6 %). L’absence de rapportage du Haut-Uélé et la faible vérification des alertes au Sud-Kivu (50 %) nécessitent un suivi rapproché.

Évolution de cas par date de début des symptômes au cours de 21 derniers jours



CARTOGRAPHIE DES CAS de 21 derniers jours



1. COORDINATION

1.1.Principales Actions

- **Kinshasa** : Tenue d'une réunion présidée par le Ministre de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale, en présence des partenaires techniques et financiers, consacrée à l'examen et à la validation du plan MVE de deuxième génération ;
- Réunion au cabinet du ministre de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale autour de son Excellence. La réunion a porté sur la présentation du plan multisectoriel de préparation et réponse des 180 jours pour la MVE 17 ;
- **Nord-Kivu** : poursuite de la préparation de la campagne de vaccination compassionnelle et réunions des sous-coordinations de Beni, Butembo et Katwa autour de la capacité d'accueil des CTE de Kitatumba et de Katwa ;
- **Ituri** : poursuite de l'évaluation du plateau technique des CTE à l'aide de l'outil 5S, 9 CTE ayant achevé leur encodage ;
- **Ituri** : participation de l'Incident Manager à une concertation de haut niveau au Gouvernorat consacrée à la **rentrée scolaire sécurisée dans le contexte de la MVE**, avec un accent sur le renforcement des capacités des acteurs du secteur éducatif et l'application des mesures de prévention dans les établissements scolaires ;
- **Ituri** : concertation de l'Incident Manager avec les **partenaires techniques et financiers** sur l'état d'avancement de la riposte, l'harmonisation des interventions, la couverture des gaps opérationnels et les modalités d'appui aux relais communautaires ;
- **Tshopo** : lancement du processus de vaccination compassionnelle contre la MVE, 2 000 doses d'ERVEBO disponibles au pays, déployées en priorité dans les ZS de Makiso-Kisangani, Kabondo, Mangobo (Tshopo) et de Buta (Bas-Uélé) ;
- **Renforcement des équipes de riposte** : poursuite de la **mobilisation, du déploiement et du redéploiement des experts nationaux et des partenaires** vers les zones prioritaires, en fonction de l'évolution épidémiologique et des gaps identifiés.

1.2. Défi majeur

Insuffisante harmonisation du déploiement des partenaires et des experts en fonction des gaps opérationnels prioritaires dans les zones et aires de santé.

2. ACTIONS DE RIPOSTE PAR PILIER

2.1.Surveillance épidémiologique

2.1.1. Principales Actions

Au terme de la journée du 19 août 2026, 1 904 alertes ont été enregistrées, dont 1 752 (92,0 %) ont été vérifiées dans les cinq provinces ayant rapportés. De ces alertes, 366 (20,9 %) ont été validées comme cas suspects et 327 (89,3%) ont été investiguées, desquelles 185 ont été transférées vers les CT/CTE.

La proportion des contacts suivis au cours des dernières 24 heures remonte à 82,9 % (16 355 vus sur 19 720 à suivre), bien qu'elle demeure en dessous du seuil de 85 % : Ituri 87,6 % (9 204/10 509), Tshopo 100,0 % (473/473) et Nord-Kivu 77,3 % (5 830/7 540). Le Haut-Uélé 56,6% (848/ 1 498) et Bas Uélé 59,5% (131/220).

2.1.2. Défis

Suivi insuffisant des contacts, particulièrement au Haut-Uélé et au Bas-Uélé, avec une couverture nationale restant sous le seuil de 85 %.

2.2.Point sur les activités de points de contrôle et points d'entrées (PoC/PoE)

2.2.1. Principales actions

- Deux (2) alertes ont été notifiées aux PoE/PoC au cours des dernières 24 heures, toutes au Nord-Kivu, dont aucune n'a été validée après investigation ; l'Ituri, le Sud-Kivu et la Tshopo

n'ont notifié aucune alerte et le Haut-Uélé n'a pas rapporté (ND). Aucun corps sans vie ni contact à problème n'a été intercepté aux points d'entrée.

Suivi des indicateurs aux PoE/PoC par province, en date du 19 août 2026				
Indicateurs	Ituri	Nord-Kivu	Sud-Kivu	Global
Proportion de PoC activés et PoE renforcés	98,3 %	100 %	100 %	98,7 %
Nombre de personnes passées aux PoE/PoC	148 032	80 917	84 432	313 381
% des voyageurs screenés	98,0 %	97,2 %	100 %	98,3 %
% des voyageurs ayant lavé les mains	98,0 %	ND	100 %	98,7 %
% des voyageurs sensibilisés	98,0 %	ND	100 %	98,7 %
Nombre d'alertes notifiées	0	2	0	2
Nombre d'alertes vivantes validées	0	0	0	0
Nombre de corps sans vie interceptés ce jour	0	0	0	0
Nombre de contacts à problèmes interceptés ce jour	0	0	0	0
% d'alertes vivantes validées référées au CT/CTE	NA	NA	NA	NA
% des corps sans vie swabés	NA	NA	NA	NA

2.2.2. Défi majeur

Insuffisance de complétude du rapportage des activités aux PoE/PoC, notamment l'absence de données du Haut-Uélé et des données partielles dans certaines provinces, limitant l'appréciation exhaustive des performances du dispositif de contrôle des mouvements de population.

2.3. Laboratoire

2.3.1. Principales actions

- **Ituri : 56 nouveaux résultats positifs** (43 vivants et 13 décès) sur 265 nouveaux échantillons reçus et analysés (**positivité : 21,1 %**) ;
- **Nord-Kivu : 18 nouveaux résultats positifs** (10 vivants et 8 décès) sur 127 échantillons analysés (**positivité de 15,0 %**) ;
- **Haut-Uélé : 7 nouveaux résultats positifs** (5 vivants et 2 décès) sur 30 échantillons analysés (**positivité de 23,3 %**).

2.3.2. Défi majeur

Forte positivité des échantillons, notamment au Haut-Uélé (23,3 %) et en Ituri (21,1 %), témoignant de la persistance d'une transmission active.

2.4. Prévention et Contrôle de l'Infection (PCI/EDS)

2.4.1. Principales actions

- **En Ituri**, 19 rings ont été ouverts sur 70 attendus (27,1 %) et 40 lieux de séjour décontaminés sur 82 identifiés (48,8 %) ; 7 dotations en kits PCI, 8 évaluations et 24

accompagnements d'ESS ont été réalisés et 106 prestataires briefés ; sur 82 alertes de décès reçues, 62 corps ont été prélevés par swab, 13 échecs et 77 EDS réalisés ;

- **Au Nord-Kivu**, 9 FOSA et 5 ménages ont été décontaminés et 5 ESS évalués ; 243 FOSA ont été accompagnées et 799 prestataires briefés, la complétude atteignant 7 zones de santé sur 12. Sur 49 alertes de décès, 46 corps ont été prélevés par swab (3 échecs pour résistance communautaire dans l'AS de Kasanga, ZS de Beni) et 47 EDS réalisés, pour 8 swabs revenus positifs ;
- **Au Bas-Uélé**, deux locaux de l'HGR de Buta (laboratoire et salle de soins) ont été décontaminés et 8 ESS sur 13 accompagnés ; la décontamination de deux ménages n'a pas pu être réalisée pour cause de résistance familiale. Sur 1 alerte de décès reçue à l'HGR de Likati, aucun corps n'a été swabé ni EDS réalisé, dû à l'opposition de la famille ;
- **À la Tshopo**, 1 ring a été ouvert autour du 15^e cas (Makiso-Kisangani) avec décontamination du ménage et de l'ESS ; 14 accompagnements d'ESS, 22 briefings de **prestataires et 4** installations d'unités de triage ont été réalisés. Sur 2 alertes de décès reçues (ZS Tshopo), 2 corps ont été swabés.

2.4.2. Défi majeur

Faible couverture des rings et des décontaminations, particulièrement en Ituri, associée à des résistances communautaires entravant les swabs, les EDS et les interventions PCI.

2.5. Continuité des soins

2.5.1. Principales actions

- **En Ituri**, 138 nouvelles admissions et 6 réadmissions ont été enregistrées pour 129 sorties, dont 36 guéris. Ainsi, 551 patients sont hospitalisés pour 965 lits, soit un taux d'occupation global de 57,1 %. Vingt-sept ambulances sur 30 sont disponibles, 14 utilisées pour 25 courses réussies sur 25 ;
- **Au Nord-Kivu**, 46 admissions ont été enregistrées (4 confirmés, dont 2 au CTE de Katwa et 2 au CT de Beni, et 42 suspects) pour 55 sorties dont 1 guéri au CT de Vuhovi. Ainsi, 196 malades sont hospitalisés pour 206 lits, soit 95,1 % d'occupation ;
- **Au Haut-Uélé**, 53 patients sont pris en charge (36 confirmés et 17 suspects) ; 52 lits des HGR de Wamba et d'Isiro ont été affectés aux CTE et un pavillon de l'HGR de Wamba aménagé, portant la capacité provinciale à 130 lits (Taux d'occupation 40,8%).
- **Au Haut-Uélé, 4 patients sont en hospitalisation ;**
- **À la Tshopo**, une nouvelle admission d'un suspect au CTE HC Kisangani porte à 5, le nombre de patients isolés pour 14 lits (35,7% d'occupation).
- **Au Sud-Kivu**, 25 cas suspects restent hospitalisés.

2.5.2. Défi majeur

Forte pression sur les capacités de prise en charge au Nord-Kivu, avec un taux d'occupation des lits de 95,1 % exposant à un risque de saturation des CT/CTE et nécessitant le renforcement rapide des capacités d'accueil et de référencement des cas.

2.6. Communication sur les risques et engagement communautaire

2.6.1. Principales actions

- **En Ituri**, 543 nouveaux contacts ont été listés autour des cas du jour et 235 personnes touchées par des entretiens de groupe et individuels dans sept zones de santé (Rwampara, Mangala, Bunia, Nia-Nia, Nizi, Bambu-mine et Mongbwalu). 3 244 personnes ont été touchées lors des visites à domicile et 5 252 lors des sensibilisations de masse ;
- **En Ituri**, le pilier SMSPS a couvert 31 des 53 nouveaux cas confirmés (58,5 %) dans 4 des 13 ZS ayant notifié, 58 nouveaux cas suspects et 15 des 36 guéris réinsérés en communauté (41,7 %) ; 70 ménages affectés ont été accompagnés et 50 enfants séparés ou orphelins suivis en communauté. À la Tshopo, deux résistances ont été levées à Mangobo et Makiso, 107 personnes ont bénéficié de psychoéducation et 1 341 personnes ont été touchées par les visites à domicile à Bondeko, Mangobo, Tshopo et Lubunga ;

- **Au Nord-Kivu**, Communication de masse et engagement de 90 leaders communautaires de trois aires de santé (Kuka, Ngadi et Boikene) à l'Etat-major commandement urbain de Beni pour le respect des mesures barrières et l'engagement communautaire dans la lutte contre la MVE ; sensibilisation de 6 personnes pour faciliter la décontamination de 3 ménages à Vuhovi et listage de 37 contacts du cas confirmé de l'AS de Ngongolio (ZS Beni) ; 26 cas ont été couverts et 60 responsables de ménage touchés.

1.1.1. Défi majeur

Couverture encore insuffisante des interventions de communication et d'accompagnement psychosocial autour des cas et des personnes affectées, notamment en Ituri, où seuls 58,5 % des nouveaux cas confirmés et 41,7 % des guéris ont été couverts par le SMSPS, avec persistance de résistances communautaires dans certains foyers.

2.7. Logistique

2.7.1. Principales actions

En Ituri, 16 véhicules offerts par l'UNICEF ont été réceptionnés pour les équipes de décontamination de six zones de santé et 856 kg de kits PECH (118 colis) livrés à la ZS de Lolwa, avec des kits PCI à Rwampara. 250 litres de carburant ont été mis à disposition des ambulances et véhicules de la riposte ;

À la Tshopo, un lit d'accouchement a été doté au CS de Madula (PK 23 RN4) et des thermoflashes livrés aux ZS de Makiso-Kisangani et de Tshopo ; les travaux de construction des unités d'isolement de Madula et de Kabondo ainsi que du CTE de grande capacité se poursuivent ;

Au Nord-Kivu, des intrants PCI offerts par FHI 360 (gants, pulvérisateurs, désinfectants, sachets et combinaisons Tyvek) ont été réceptionnés et livrés aux équipes EDS de sept zones de santé. Une tente a été livrée à la coordination de la riposte et des intrants nutritionnels à Oicha. La construction du triage de l'HGR de Vuhovi (ULB Coopération) et la réhabilitation du CT de l'HGR de Musienene (MSF France) se poursuivent. Des kits PECH aux ZS de Butembo et de Katwa par l'UNICEF ;

Au Bas-Uélé, le pilier a colisé les intrants PCI destinés à la ZS de Viadana et assuré le transport des échantillons des zones de santé vers le site Rad-One.

2.7.2. Défis

Insuffisance persistante des moyens logistiques et des intrants essentiels dans certaines zones prioritaires, nécessitant le renforcement de l'approvisionnement et de leur acheminement en temps opportun.

2.8. Sécurité

2.8.1. Principales actions

- Au Nord-Kivu, une équipe EDS a été agressée dans l'AS de Bunji, à Kasanga Tuha (plusieurs blessés et un décès probable), l'équipe étant partie sans solliciter d'accompagnement sécuritaire. Pour cela, le pilier a assuré six couvertures sécuritaires d'équipes EDS et de décontamination à Beni et à Katwa, rétabli l'ordre public au CS de Ndindi menacé d'incendie et mis à jour la cartographie des sites d'hébergement recommandés pour Beni et Butembo. En Ituri, un véhicule EDS a été caillassé au village de Mungamba (ZS de Komanda). C'est ainsi que l'Ituri, le Haut-Uélé, la Tshopo et le Bas-Uélé n'ont pas transmis de données consolidées de sécurité.

2.8.2. Défi majeur

Persistance des incidents sécuritaires visant les équipes de riposte, nécessitant le renforcement de l'analyse des risques et de l'accompagnement sécuritaire des interventions sensibles.

2.9. PSEA (Prévention contre l'Exploitation et les Abus Sexuels)

2.9.1. Principales actions

- En Ituri, 77 personnes ont bénéficié d'un briefing PSEA (30 participants dont 12 femmes à Bunia et 47 dont 20 femmes à Rwampara) et toutes ont signé le code de bonne conduite ; 210 personnes ont été sensibilisées en communauté (157 à Bunia, 15 à Rwampara et 38 femmes enceintes à Gety). La couverture demeure limitée à 4 des 36 zones de santé (11,1 %) et seuls deux partenaires (OMS et Africa CDC) rapportent leurs activités PSEA.

2.9.2. Les défis

Couverture encore insuffisante des activités PSEA, limitée à 4 zones de santé sur 36 en Ituri, absence de cartographie des intervenants, insuffisance de supports de sensibilisation de masse et manque de moyens de transport et d'équipement informatique pour le pilier.

2.10. Base des données

2.10.1. Principales actions :

- **Compilation, consolidation et analyse quotidienne des données** épidémiologiques et opérationnelles transmises par les provinces affectées, avec contrôle de leur complétude et de leur cohérence avant intégration dans le SitRep national ;
- **Poursuite de l'harmonisation et du nettoyage des bases de données**, notamment la réconciliation des cas, décès et zones de santé d'appartenance, ainsi que la ventilation des données non encore attribuées ;
- **Mise à jour des bases de données et tableaux de bord de suivi** des principaux indicateurs de la riposte afin d'appuyer la prise de décision de la Coordination ;
- **Suivi de la transmission quotidienne des données par les DPS** et relance des provinces/piliers présentant des données manquantes, incomplètes ou discordantes ;
- **Production et diffusion du SitRep national et de la note d'information**, après consolidation et validation des données de la riposte.

2.10.2. Défi majeur

Insuffisance persistante de la complétude et de la cohérence des données, avec des discordances nécessitant une harmonisation régulière des bases.

MESSAGES CLES

- La transmission de la MVE demeure active, avec 81 nouveaux cas confirmés et 40 décès confirmés au cours des dernières 24 heures, dont 23 décès communautaires et 17 intra-CTE, portant le cumul national à 5 290 cas confirmés et 2 516 décès.
- L'Ituri demeure l'épicentre de l'épidémie, concentrant 84,1 % des cas cumulés et 69,1 % des nouveaux cas, avec 28 des 36 zones de santé (77,8 %) déjà affectées.
- Les performances de la surveillance restent sous-optimales : 89,3 % des cas suspects ont été investigués, tandis que le suivi des contacts s'établit à 82,9 %, en dessous du seuil opérationnel de 85 %, avec des disparités importantes entre provinces.
- La persistance des décès communautaires, l'insuffisance du suivi des contacts et la transmission active dans plusieurs foyers appellent à intensifier les interventions prioritaires de surveillance, PCI/EDS, prise en charge, engagement communautaire et logistique, afin d'interrompre rapidement les chaînes de transmission.

CHRONOLOGIE DES FAITS CLÉS

- Du 24 avril au 15 mai 2026, l'épidémie est passée de la détection des premiers cas suspects à la confirmation biologique du virus Ebola Bundibugyo, conduisant à la déclaration officielle de la 17^e épidémie de Maladie à Virus Ebola en République Démocratique du Congo.
- Entre le 17 et le 18 mai 2026, les autorités nationales, avec l'appui des partenaires, ont renforcé la riposte par la déclaration de l'urgence de santé publique de portée nationale puis continentale, accompagnée de la mobilisation des 64 et de soutien.



TASK FORCE PRESIDENTIELLE EBOLA 17
Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale
Système de gestion de l'incident MVE17

Incident Manager

Professeur Dr AHUKA MUNDEKE Steve
E-mail : steve.ahuka@unikin.ac.cd

Incident Manager Adjoint

Professeur Dr Akilimali Zalagile Pierre

Chargé des opérations

Dr Kombe NGWAMA John

Equipe rédaction

Professeur Dr Mulangu Katulumba Félix-Médard
Dr Katusi Biselenge Jules
Madame Mayele Afua Marie
Dr Diur Mananashi Floryan
Mr Kamuina Kebela John



Contact :
www.sante.gouv.cd
contact@sgiebola17.org

Numéro vert : 151.